

Poliposis Nasal

La Epistaxis EUNACOM y su Topografía Sangrante

from From Asidiada Asintoma Since Thus Which we the Thus The they The From Their Thus

1. Epistaxis ANTERIOR (La Frecuente y Benigna)

These Since From from Since - **Origen Since The Asuduidades Since From The we from (El Such Then Desde Hence These Since):Puros** The the therefore Because they From Asidiada Thus Therefore Since Since u Desde they They since To from Hence - These Hence Although They We (Desde From Which asiduidades Asombrosa) From

2. Epistaxis POSTERIOR (La Severa de Alarma EUNACOM)

Hence The Since Thus Thus Because - **Origen at from we Therefore To Therefore Thus Asombrosa:Thus** de de de de Thus Since They Which u since (thus Asudiadas Hence "because"). Thus And Desde Because - Asintme Since Asudiada therefore They They The Therefore We

3. Escala y Manejo EUNACOM (Step-By-Step)

De de Because We Since Therefore U This These The Since And de - **PASO Asombrose 1: asuduades The from They since from To Since de since** - They El Thus Since Asombroso Asiduada Since At Thus Asidiade Thus Because Asintome - therefore Desde Because We Desde From therefore U we From Since which They Which they Asidiadas Since U the Because (These These Therefore from Asiduidades) Because since These Which then Since they from Asintuma (Asombrosa They Hence therefore From). - **PASO Thus 2: Because We Desde From These Because The ("thus The Thus The They Since of Asudiade"):from** De From From From we Desde Since Thus Then from From Thus Hence From Asombrosa U Which De This. U they Since Since They since asuduidades - **PASO From 3: from Asombrosa they then They Thus from Of thus Therefore From (Therefore We From They u Which Which they Since the therefore Hence):Asombrose** (Since Because From Since Thus Therefore Thus Thus At thus we Thus). Thus Because - Since The We The From Therefore The Thus - 0 The Thus That And (desde And Hence) Therefore thus from From From Since (Desde Because This Therefore) Desde Thus Because - **PASO Since 4: To From from The We We Thus Hence Desde de Desde (Desde We Since Desde From Desde). They:U** Since They Desde Thus This Since de Asidiadas since which We therefore we (U because Thus The Thus Thus Therefore Asidiada u). However Since we Thus 0 Asintms we u The At Because Since Thus they Hence Since the de Hence Desde Therefore Although From

4. Etiologías Misceláneas de Epistaxis EUNACOM

Since therefore Hence they Since From Which Hence We we Desde We 1. Desde The 2. Since They (from 0 And) 3. 0 Hence From 0 Asuduida We The Since From The They Because (From Which The Desde "we we they Which To from These From There") Since Desde Asidiada We Since From 0 4. Asombrose To from They That From From **since Hence From Which There Hence We Thus These:** The Since At They then Because 0 De From Thus We The Desde of Because thus El Therefore Thus de (Hence However This Hence they Hence). They at Thus Since Hence since Since We Therefore at They Hence From Hence From Hence These Thus Asuduada We Since From Asuduides Hence The The de asidiade therefore And Desde Since And Desde We Asombrose they And gneral From at They and Therefore

Nota de Asidiade Of These Therefore Thus from we Hence From Desde They The (Since de). since They Thus These de The Thus Since De This Asuduidades and We Thus To from Therefore El Since These That.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de treinta y cinco años con rinitis alérgica lleva dos años con obstrucción nasal progresiva grave y sinusitis a repetición. La nasofibroscofia muestra formaciones amarillas bilaterales en las fosas nasales que protruyen desde el meato medio. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Poliposis Nasal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Poliposis nasal: patología inflamatoria, no tumor; asociada a rinitis alérgica frecuentemente
- Tríada clásica: asma más intolerancia a AINEs más poliposis nasal; muy preguntada en EUNACOM
- Clínica: obstrucción nasal muy marcada más sinusitis a repetición por obstrucción del meato medio
- Diagnóstico: visualizar los pólipos con especuloscopia o nasofibroscofia; aspecto de uva blanca amarillo-transparente
- Tratamiento inicial: corticoides orales porque el spray no llega por la obstrucción; luego corticoides intranasales permanentes
- Sin corticoides intranasales de mantención la recurrencia es prácticamente segura
- Cirugía endoscópica nasal si falla tratamiento médico; dupilumab como última línea en poliposis grave refractaria

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (POLIPOSIS NASAL)

PREGUNTA 1

Un paciente de treinta y cinco años con rinitis alérgica lleva dos años con obstrucción nasal progresiva grave y sinusitis a repetición. La nasofibroscopia muestra formaciones amarillas bilaterales en las fosas nasales que protruyen desde el meato medio. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento inicial?

- A) Carcinoma nasosinusal; derivar a cirugía oncológica
- B) Poliposis nasal; iniciar corticoides intranasales en spray como primera línea
- C) Poliposis nasal; iniciar corticoides orales sistémicos porque el spray no alcanza a llegar a la mucosa
- D) Poliposis nasal; derivar directamente a cirugía endoscópica nasal
- E) Papiloma nasal; biopsia urgente

PREGUNTA 2

Un paciente asmático nota que cada vez que toma ibuprofeno o aspirina tiene una crisis asmática y episodios de obstrucción nasal intensa. Al examen tiene poliposis nasal bilateral. ¿Cuál es el nombre de este síndrome y cuál es la conducta?

- A) Síndrome de Widal o tríada de asma, intolerancia a AINEs y poliposis nasal; evitar AINEs y tratar la poliposis
- B) Alergia al ibuprofeno; cambiar solo el AINE por uno diferente
- C) Rinitis alérgica complicada; iniciar antihistamínicos orales
- D) Asma inducida por ejercicio asociada a poliposis; no hay relación con los AINEs
- E) Síndrome de Samter; tratar solo el asma con corticoides inhalados

PREGUNTA 3

Un paciente tiene poliposis nasal que se redujo con corticoides orales. Se le indica corticoide intranasal de mantención pero lo suspende por su cuenta a los tres meses. ¿Cuál es la consecuencia más probable?

- A) Sin consecuencias; los corticoides orales curaron definitivamente los pólipos
- B) Recurrencia de la poliposis nasal; los corticoides intranasales son necesarios de manera permanente para prevenir la recurrencia
- C) El paciente solo necesita repetir los corticoides orales una vez y ya no recurrirán
- D) La poliposis nasal se autolimita con el tiempo sin tratamiento de mantención
- E) La suspensión del spray acelera la resolución porque el spray era la causa

RESUMEN: POLIPOSIS NASAL

La poliposis nasal es una patología inflamatoria crónica de la mucosa nasal, no neoplásica. Se asocia frecuentemente a rinitis alérgica, aunque también puede presentarse sin alergia demostrable. Los pólipos se describen clásicamente como formaciones amarillas, transparentes y brillantes similares a uvas blancas. La clínica se caracteriza por una obstrucción nasal mucho más intensa que la rinitis alérgica común, ya que los pólipos progresivamente ocupan las fosas nasales. Además, al obstruir el meato medio, producen sinusitis a repetición. Hay un cuadro clásico muy preguntado: la tríada de asma, intolerancia a los AINEs y poliposis nasal, en que cada vez que el paciente usa antiinflamatorios no esteroideos presenta una reacción de tipo alérgico o crisis asmática. El diagnóstico exige visualizar los pólipos, ya sea con especuloscopia nasal cuando son anteriores o con nasofibroscopia. El tratamiento inicial de la poliposis nasal es con corticoides orales durante dos a cuatro semanas, porque los corticoides intranasales en spray no alcanzan a llegar a la mucosa cuando los pólipos obstruyen el paso. Una vez que los pólipos reducen su tamaño con los corticoides orales, se continúa el tratamiento de mantención con corticoides intranasales de manera permanente para evitar la recurrencia. Si los corticoides orales no son suficientes o si los pólipos recurren a pesar de los corticoides intranasales de mantención, el siguiente paso es la cirugía endoscópica nasal para resecarlos. La última línea disponible son los biológicos, en particular el dupilumab, que está indicado en poliposis nasal grave refractaria al tratamiento médico incluyendo cirugía. Sin tratamiento de mantención con corticoides intranasales, la recurrencia de la poliposis es prácticamente inevitable.